당뇨, 오늘부터 함께 관리합니다

당뇨병 첫 외래 안내 — 진단 기준과 합병증, 오늘 하는 검사, 약과 함께 할 일까지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진단 직후가 가장 중요합니다

당화혈색소(지난 2~3개월 평균 혈당)를 1%만 낮춰도 눈·콩팥·신경 합병증이 크게 줄어듭니다

37%

합병증 위험 감소

당화혈색소를 1% 낮췄을 때 눈·콩팥·신경 합병증(미세혈관 합병증) 위험이 줄어든 정도

오늘의 메시지

당뇨병은 합병증이 무서운 병이지만, 합병증은 **예방할 수 있습니다**. 진단은 끝이 아니라 관리의 시작입니다.

처음 1~2년이 오래 갑니다

진단 초기에 잘 조절하면 그 효과가 오래 남는다는 연구 결과가 있습니다. 약·식사·운동·검사 네 가지를 함께 맞추면 합병증 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

Tip · 당화혈색소는 검사 결과지에 'HbA1c'로 적혀 있습니다.

근거 · 영국 UKPDS 35(BMJ 2000) · UKPDS 80 장기 추적(NEJM 2008)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

당뇨병 진단이 뜻하는 것

인슐린이 잘 듣지 않고(저항성), 만드는 양도 줄어든 상태 — 둘 다 관리할 수 있습니다

인슐린 저항성

간·근육·지방이 인슐린에 둔감해집니다.

- 내장지방이 늘면 인슐린이 잘 듣지 않습니다
- 췌장은 이를 메우려 인슐린을 더 짜냅니다
- 체중 감소·운동으로 가장 잘 좋아지는 부분입니다
- 의지가 약해서 생기는 병이 아닙니다

vs

인슐린 분비 감소

진단 때 췌장 세포 기능이 약 50% 줄어 있는 경우가 많습니다.

- 인슐린을 만드는 세포가 점점 지칩니다
- 유전적 소인과 생활습관이 겹쳐 생기는 대사질환입니다
- 일찍 부담을 덜어 주면 남은 기능을 오래 지킬 수 있습니다
- 두 문제 모두 약과 생활습관으로 늦추거나 되돌릴 수 있습니다

Tip · 가족 중 당뇨병이 있다면 진료 때 알려 주세요 — 관리 계획에 도움이 됩니다.

근거 · Diabetes 2009 · 대한당뇨병학회 진료지침 2023

인슐린을 미루지 않아야 할 때

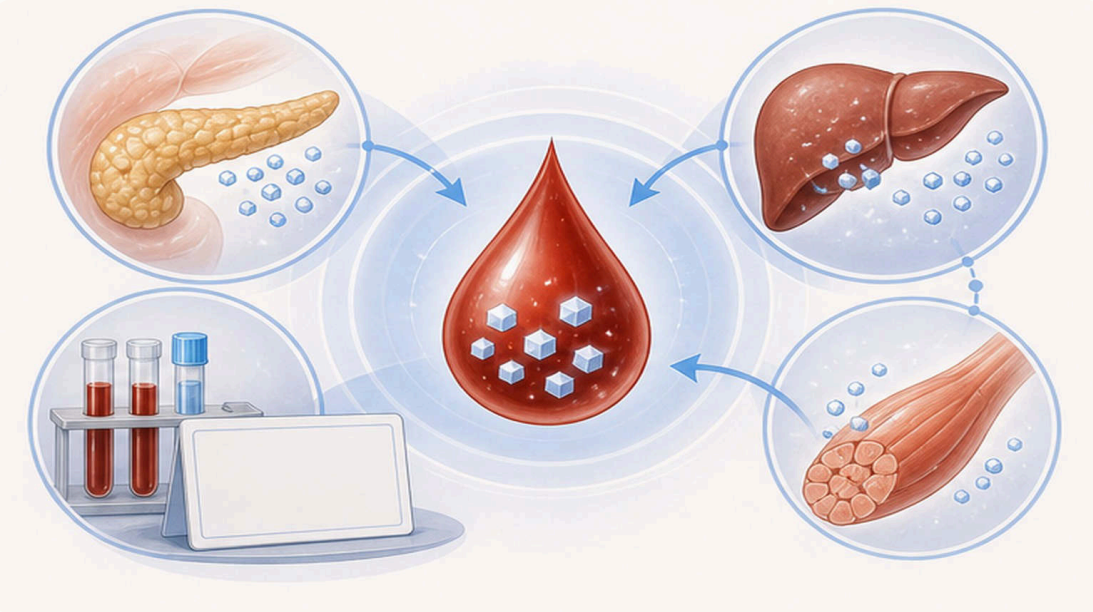
몸이 에너지를 제대로 쓰지 못하는 과이화 증상을 살핍니다.

숫자만 기다리지 않습니다

물을 많이 마시고 소변을 자주 보거나 탈수·원치 않는 체중 감소가 생기면 인슐린을 고려합니다. 과거 HbA1c 9% 기준에만 묶어 기다리지 않습니다.

분비능과 회복을 함께 봅니다

인슐린 분비가 심하게 부족한 췌도부전이면 인슐린이 꼭 필요합니다. 과이화 상태가 좋아지고 분비능이 회복된 2형당뇨병은 의료진 판단으로 비인슐린 치료로 바꿀 수 있습니다.



혈당과 인슐린 작용의 관계를 설명하는 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

주사제를 고를 때 인슐린 분비능도 봅니다

강의의 C-peptide 수치는 약의 반응을 살핀 연구 조건입니다.

함께 보는 상황	강의에서 설명한 판단
마른 고령 환자 사례	72세·BMI 21.4·공복 C-peptide 0.65 ng/mL 사례에서 인슐린을 선택했습니다.
GLP-1 계열의 혈당 반응	공복 C-peptide ≤0.75 ng/mL에서는 혈당 강하 반응이 낮아질 수 있다고 소개했습니다.
수치의 적용 범위	낮은 C-peptide를 GLP-1 계열의 절대 금기나 체중감량 효과가 없다는 뜻으로 바꾸지 않습니다.
저혈당을 함께 살피기	고령·콩팥기능 저하 상태에서 식사를 못하면서 설포닐우레아를 계속 먹으면 저혈당이 오래 반복될 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

네 가지 기준 중 하나만 맞아도 진단합니다

두 번 확인하면 진단합니다 — 전형적 증상과 혈당 200 이상이면 한 번으로도 진단

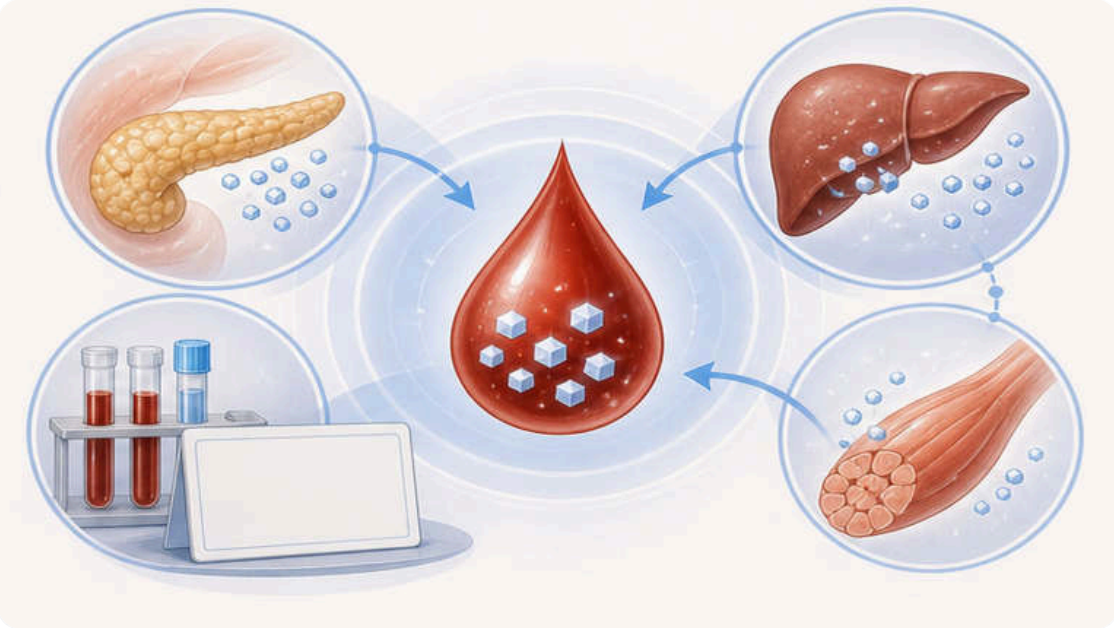


그림 · 혈당은 췌장·간·근육이 함께 조절하고, 혈액검사로 확인합니다(설명용 그림).

1 당화혈색소 6.5% 이상 `2~3개월 평균`

정상 5.6 이하 · 전단계 5.7~6.4. 빈혈·콩팥병이 있으면 부정확할 수 있어 다른 검사를 함께 봅니다.

2 공복혈당 126 이상 `8시간 금식`

정상 100 미만 · 공복혈당장애 100~125. 가장 흔히 쓰는 기준입니다.

3 당부하 2시간 200 이상 `포도당 75g`

정상 140 미만 · 내당능장애 140~199. 임신성·초기 당뇨 진단에 유용합니다.

4 아무 때나 혈당 200 이상 + 증상 `한 번으로 진단`

심한 갈증·잦은 소변·많이 먹음, 또는 이유 없는 체중 감소가 함께 있을 때입니다.

Tip · 한국인은 공복혈당보다 식후 혈당이 먼저 오르는 경우가 많아, 공복 110~125나 당화혈색소 6.1~6.4%면 당부하검사를 권합니다(단위 mg/dL).

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(선별·진단) · 진료지침 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약을 일찍 함께 쓰는 이유

서로 다른 작용을 이용해 혈당 조절 실패를 줄이는 전략입니다.

HbA1c ≥7.5%

초기 병용을 고려하는 혈당

당화혈색소가 7.5% 이상이거나 개인 목표보다 1.5%p 이상 높으면 처음부터 약을 함께 쓰는 것을 적극적으로 고려한다고 설명했습니다.

단독과 병용

먹는 비인슐린약의 혈당 강하 정도는 약 0.5~1.0%p, 주사제는 약 1.0~2.5%p로 소개했습니다. 현재 혈당과 목표의 차이도 약 선택에 반영합니다.

치료 계획의 일부

약을 여러 개 쓰는 것은 서로 다른 작용을 활용하는 선택입니다. 효과와 부작용을 보고 계획을 조정합니다.

당뇨병과 고혈압이 함께 있을 때

강의에서 제시한 혈압 조절 목표입니다.

<130/80 mmHg

혈압도 혈당과 함께 관리

당뇨병 동반 고혈압 목표를 130/80 mmHg 미만으로 강화한 변화를 설명했습니다. 이전의 낮은 위험군 140/90 목표와 구분합니다.

치료를 조정하는 자료

혈압 기록과 복용 중인 약, 어지럼 같은 증상을 함께 보며 치료를 조정합니다.

심장·뇌혈관·콩팥 관리

혈당만이 아니라 혈압과 동반질환을 함께 관리하는 방향을 강조했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

항암치료 중 혈당이 오르면 원인을 구분합니다

정재호 강의 · 스테로이드와 표적치료제의 고혈당은 접근이 다릅니다.

스테로이드 사용

항구토제 덱사메타손 등을 반복 사용하는 상황

- 교재에는 덱사메타손 10~20mg 등의 사용이 소개됐습니다.
- 주로 식후 혈당이 높아지는 양상을 살핍니다.
- 먹는 당뇨약을 조절하거나 심하면 인슐린을 사용한다고 설명했습니다.

vs

PI3K/AKT 억제제

알펠리십·카피바설팁·이나볼리십 등

- 인슐린 신호전달 경로에 작용해 혈당이 오를 수 있습니다.
- 메트포민을 먼저 사용하고 지속되면 추가 치료·내분비내과 연계를 설명했습니다.
- 이 약제 상황에서의 인슐린 회피 접근을 모든 당뇨병에 적용하지 않습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

첫 외래에서 출발점을 확인합니다

지금의 혈당 수준과 이미 시작된 합병증이 있는지 한 번에 점검합니다(일부는 채혈·예약으로 진행)

혈당 · 당화혈색소

공복혈당과 최근 2~3개월 평균인 당화혈색소로 지금 조절 수준과 첫 목표치를 정합니다.

혈압 · 콜레스테롤

당뇨는 혈관병입니다. 혈압과 나쁜 콜레스테롤(LDL)을 함께 관리해야 심근경색·뇌졸중을 막습니다.

콩팥 — 소변·혈액검사

콩팥 합병증은 초기에 증상이 없습니다. 소변 속 단백(알부민)과 콩팥 거르는 기능을 재서 가장 먼저 신호를 잡습니다.

눈 · 발 검진

진단 때 눈 속(안저) 검사를 한 번 하고, 발 감각·맥박을 확인합니다. 망막·신경 합병증을 일찍 찾습니다.

Tip · 검사 결과는 다음 진료 때 함께 보며 나의 목표치를 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 초기 평가 권고 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

당뇨가 무서운 진짜 이유 — 여섯 가지 합병증

높은 혈당이 수년~수십 년 쌓이면 작은 혈관·큰 혈관·신경이 상합니다

눈(망막병증)

실명을 일으키는 주요 원인입니다. 진단 뒤 해마다 눈 속(안저) 검사를 받습니다. 진행하면 레이저·주사 치료가 필요합니다.

콩팥(신증)

한국 투석 원인 1위입니다. 소변 속 단백 → 콩팥 기능 저하 순으로 진행하며, 일부 당뇨약·혈압약이 진행을 늦춥니다.

신경(신경병증)

발 저림·통증·감각 저하부터 어지럼·소화 장애까지 옵니다. 절반 이상이 증상이 없어 정기 발 검사가 필요합니다.

심장·뇌혈관

협심증·심근경색·뇌졸중 위험이 2~4배 높아지고, 당뇨병 환자의 주요 사망 원인입니다.

당뇨발

신경 손상 + 혈관 좁아짐 + 감염이 겹쳐 사고가 아닌 다리 절단의 가장 흔한 원인이 됩니다. 매일 발을 살핍니다.

급성 합병증 — 응급

감염·금식·약 중단으로 혈당이 치솟거나(케톤산증·고삼투압 상태) 너무 떨어질 수 있습니다. 의식 변화·심한 구토는 응급실.

Tip · 합병증은 초기에 증상이 없습니다 — 해마다 눈·콩팥·발 검사를 받으세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 대한신장학회 투석 등록자료 · 당뇨병 콩팥병 팩트시트 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

매일 발을 보고 작은 상처도 보여 주세요

김태오 강의 · 발의 감각과 혈액 공급을 함께 살핍니다.

매일 하는 발 관리

감각이 둔한 발의 상처와 화상을 예방합니다.

- 상처와 피부색 변화를 매일 살핍니다.
- 청결·보습을 유지하고 과한 압력을 피합니다.
- 핫팩을 직접 대지 않습니다. 감각이 둔한 발은 화상을 입을 수 있습니다.

vs

진료를 서두를 변화

걷는 동안의 통증과 쉴 때의 통증을 구분합니다.

- 반복되는 다리 통증, 낫지 않는 상처를 보여 주세요.
- 피부가 검게 변하거나 쉴 때도 발이 아프면 혈류 문제를 평가합니다.
- 말초동맥질환에 휴식기 통증·괴저 또는 2주 넘는 궤양이 동반되면 만성 사지위협 허혈을 고려합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

다리가 불편하면 혈관검사를 고려합니다

김태오 연자 Q&A · 당뇨병의 비전형적인 다리 증상도 평가합니다.

살펴볼 조건	연자 Q&A의 설명
증상이 없어도 고려하는 경우	50세 이상, 또는 흡연·고혈압·이상지질혈증·당뇨 유병 10년 이상·미세혈관 합병증이 있는 경우 발목상완지수(ABI)를 고려합니다.
ABI 결과	0.9 미만 또는 1.4 초과는 의뢰를 고려하는 기준으로 답했습니다. 혈관 석회화가 있으면 수치가 높게 나올 수 있습니다.
상처·휴식기 통증	ABI 수치와 관계없이 신속히 평가합니다. 필요하면 발가락상완지수나 초음파 등으로 살핍니다.
치료 협력	혈류가 부족한 상처는 상처 관리뿐 아니라 혈관 재개통과 여러 진료과의 협력이 필요할 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

목·겨드랑이와 정강이 피부도 살핍니다

정준민 강의 · 피부 모양은 혈액검사와 다른 증상에 더하는 단서입니다.

목·겨드랑이의 두꺼워짐

회갈색으로 변하고 벨벳처럼 두꺼워지는 흑색극세포증은 인슐린 저항성의 단서입니다. 다른 원인과의 감별도 함께 합니다.

정강이의 갈색 흔적

당뇨피부병증은 붉은 반점이 갈색 위축 흔적으로 남는 모습입니다. 강의에서는 당뇨 환자의 약 30~40%에서 관찰된다고 소개했습니다.

정강이 앞의 황갈색 판

당뇨지방생괴사는 황갈색의 위축성 판으로 보일 수 있으며, 혈당 조절 정도와 무관하게 생길 수 있습니다.

손과 발의 뻣뻣함

피부가 밀랍처럼 두꺼워지고 관절이 뻣뻣해질 수 있습니다. 양 손바닥이 잘 붙지 않는 모양은 기도손 징후로 소개했습니다.

중증 고혈당과 케톤산증은 별도 치료가 필요합니다

정재호 강의 · 항암제 종류와 중증도를 함께 확인합니다.

심한 상황에서 필요한 치료

PI3K/AKT 억제제 관련 고혈당이라도 중증이거나 케톤산증이면 경구약을 중단하고 인슐린·수액 치료가 필요하다고 교재는 설명했습니다.

면역항암제와 검사

면역관문억제제는 드물게 1형당뇨·케톤산증을 일으킬 수 있습니다. 항암 전·중 공복혈당과 HbA1c를 살피고 항암제·스테로이드 일정을 함께 알립니다.



항암 일정과 함께 공복·식후 혈당의 흐름을 살핍니다.

함께 관리할 네 가지 — 혼자 하지 않습니다

네 가지가 맞물려야 혈당이 안정됩니다. 한 번에 다 바꾸지 않고 하나씩 같이 만들어 갑니다



식사 — 접시법

½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물. 굶지 않고 균형을 맞추는 것이 핵심입니다.



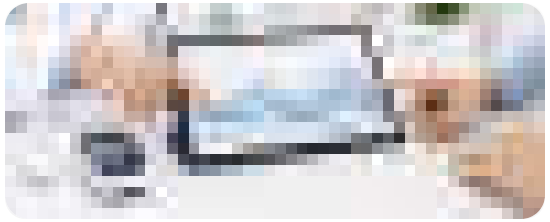
운동 — 주 150분

빠르게 걷기 같은 중강도 운동 + 주 2회 근력 운동. 식후 10분 걷기부터 시작합니다.



약 — 부담 없이 시작

메트포민으로 시작하는 경우가 많고, 체형·다른 질환에 맞춰 첫 약을 함께 고릅니다.



혈당 재기 — 내 흐름 알기

음식·운동·약의 효과를 기록으로 확인하고 다음 진료 때 함께 봅니다.

Tip · 네 가지 중 가장 쉬운 것 하나부터 이번 주에 시작해 보세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(생활습관 + 약 병행) · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022

첫 약은 내 몸의 상태에 맞춰 고릅니다

강의는 메트포민을 모든 사람의 필수 첫 약으로 정하던 권고의 변화를 소개했습니다.

함께 보는 기준

심장·콩팥병, 체중, 저혈당 위험과 부작용, 비용·복용 편의성을 함께 고려합니다. 메트포민 외의 계열을 우선할 상황도 있습니다.

메트포민의 역할

오랜 사용 경험과 혈당 강하 효과, 저렴한 약가를 가진 중요한 선택지입니다. 금기나 부작용 우려, 다른 계열을 먼저 쓸 동반질환이 없는지 살핍니다.



여러 치료 선택지 중 동반질환과 생활에 맞는 약을 함께 고릅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

메트포민 — 첫 약은 상태에 맞춰 고릅니다 (아산28 민세희)

40년 넘게 검증된 약입니다. 저혈당·체중 증가가 거의 없고, 천천히 늘려 불편을 줄입니다

1

어떤 약인가요

간에서 당이 과하게 만들어지는 것을 줄이고 인슐린이 잘 듣게 합니다. 당화혈색소를 약 1.0~1.5% 낮춥니다.

체중 중립 · 저혈당 거의 없음

2

어떻게 먹나요

500mg 한 번으로 시작해 1~2주마다 천천히 늘립니다. 속이 불편할 수 있어 식사와 함께 먹습니다. 설사·속쓰림이 심하면 천천히 녹는 약(서방형)으로 바꿀 수 있습니다.

스스로 끊지 말고 알려 주세요

3

심장·콩팥이 걱정되면

심부전·콩팥병이면 효과가 입증된 SGLT2 억제제를, 심근경색 같은 혈관병이면 효과가 입증된 SGLT2 억제제나 GLP-1 계열을 처음부터 먼저 고릅니다. 콩팥 기능이 많이 떨어졌거나 조영제 검사 전후에는 메트포민을 잠시 멈춥니다.

다른 질환에 맞춰 함께 정함

Tip · 약을 먹고 속이 불편하면 참지 말고 다음 진료 전에라도 연락 주세요.

근거 · 영국 UKPDS 34(Lancet 1998) · 대한당뇨병학회 2025 합의문 · 미국·유럽당뇨병학회 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

콩팥기능과 식사량에 맞춰 약을 조정합니다

민세희 강의 · 저혈당과 메트포민의 콩팥기능 조건을 함께 살핍니다.

함께 보는 조건	강의의 설명
eGFR <30 mL/min/1.73m²	메트포민을 중단하는 조건으로 설명했습니다.
eGFR 30~45 mL/min/1.73m²	새로 시작할 때 주의하고, 하루 최대 1,000mg 이하로 조정한다고 설명했습니다.
식사를 못하는 고령·콩팥병 환자	설포닐우레아를 계속 복용하면 저혈당이 오래 반복될 수 있습니다. 식사량과 혈당을 보고 진료에서 약을 조정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

체형과 다른 질환에 맞춰 약을 고르고 더합니다

첫 약으로도, 메트포민에 더하는 약으로도 쓰는 네 가지 주요 약

SGLT2 억제제

당을 소변으로 내보냅니다. 심부전·콩팥병이 있으면 효과가 입증된 약을 혈당과 관계없이 먼저 씁니다. 체중·혈압도 내려갑니다. 요로·생식기 감염에 주의합니다.

GLP-1 계열 주사

주 1회 또는 매일 맞습니다. 혈당을 크게 낮추고 체중도 함께 줄며, 효과가 입증된 약은 심혈관 사망도 줄입니다. 비만이면 마운자로 같은 이중 작용 주사도 고려합니다.

DPP-4 억제제

당화혈색소를 약 0.7~0.9% 낮춥니다. 체중 변화·저혈당이 거의 없어 어르신·마른 분에게 먼저 씁니다. 심혈관 사망을 줄이는 근거는 없습니다.

설폰요소제

남은 인슐린 분비를 촉진합니다. 마른 체형만으로 고르지 않으며 심한 분비 부족·체중감소·다뇨는 인슐린 필요성을 평가합니다. 저혈당·체중 증가에 주의합니다.

(아산28 민세희)

Tip · 어떤 약을 쓸지는 체형, 심장·콩팥 상태, 저혈당 위험, 비용을 함께 보고 정합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2025 합의문(약물치료) · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022 · 아시아인 DPP-4 메타분석 2013

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

먹는 약 네 가지는 조건을 갖춰 고려합니다

먹는 약 세 가지로도 목표에 못 미치고 주사치료가 어려울 때의 선택입니다.

주사치료가 어려운 상황

경구 3제 이후에도 혈당 목표에 도달하지 못하면서 주사치료를 시행하기 어려운 경우에 제한적으로 고려합니다.

과이화 증상이 없음

탈수·원치 않는 체중 감소 같은 과이화 증상이 없는 상황을 전제로 합니다.

중등도 고혈당

강의는 비교적 중등도인 고혈당의 예로 HbA1c 8.0% 미만을 들었습니다.

분비능과 약의 부담

뚜렷한 췌도부전이 의심되지 않아야 합니다. 효과와 부작용, 복약 부담을 함께 보며 조정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약을 줄일 때도 함께 계획합니다

안정적인 목표 달성 뒤 감량하고, 혈당이 나빠지면 신속히 다시 강화합니다.

1

안정성 평가

혈당 목표가 안정적으로 유지되는지 봅니다.

2

부담 줄이기

저혈당·부작용·복약 부담을 살펴 단계적 감량을 고려합니다.

3

보호 목적 확인

심장·콩팥 보호 약이나 꼭 필요한 인슐린은 혈당만 보고 끊지 않습니다.

4

추적과 재강화

감량은 의료진과 상의하고 혈당이 악화되면 빠르게 치료를 다시 강화합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

무엇을 더하고 무엇을 줄일까요

완벽한 식단이 아니라 매 끼니의 작은 선택이 쌓입니다 — 진단 직후부터 시작하면 가장 효과적

늘리기

혈당을 안정시키는 선택

- 접시법 — ½ 채소, ¼ 단백질, ¼ 통곡물
- 채소 먼저 먹기 — 식후 혈당이 덜 오름
- 식이섬유 하루 25g — 채소·통곡물·콩
- 물·무가당 음료로 갈증 해결
- 식사 시간 일정하게 · 식후 10분 걷기

vs

줄이기

혈당을 급하게 올리는 선택

- 흰밥·흰빵·국수를 많이 먹는 것
- 콜라·믹스커피 같은 단 음료 · 과일주스·말린 과일
- 야식·폭식 — 식후 혈당 급등
- 국물·젓갈 과다 — 혈압까지 나빠짐
- 과음 — 저혈당·간 부담

Tip · 끼니를 거르면 다음 끼니에 혈당이 더 크게 오릅니다 — 거르지 마세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 영양요법 · 미국당뇨병학회 영양 합의 2019

숫자로 함께 확인하는 첫 목표치

목표는 사람마다 다릅니다 — 나이·다른 질환·저혈당 위험을 보고 함께 조정합니다(일반 성인 기준)

항목	목표	이렇게 봅니다
당화혈색소	대부분 6.5% 미만	나이가 많거나 저혈당 위험이 크면 저혈당을 피하려고 목표를 더 높게(느슨하게) 잡습니다. 내 목표는 진료 때 정합니다
혈당	공복 80~130 · 식후 180 미만	한 끼보다 평균과 흐름이 중요합니다. 혈당 기록으로 봅니다
혈압	130/80 mmHg 미만	어지럼·기립저혈압·취약성·부작용에 맞춰 개별화합니다. 가정혈압을 같은 시간에 잽니다 (아산28 민세희)
LDL 콜레스테롤	100 미만 · 고위험 70 미만 · 심근경색을 겪었으면 55 미만 · 뇌경색·일과성 허혈발작은 70 미만(원인 확인), 재발 위험이 높으면 55 미만까지	혈관을 지키려 콜레스테롤약(스타틴)을 함께 쓰는 경우가 많습니다

Tip · 목표치와 저혈당 대처는 목표·저혈당 안내문을 드립니다 — 검사 결과와 비교해 보세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 목표치 · 한국지질·동맥경화학회 2025 · 미국당뇨병학회 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘이 끝이 아닙니다 — 함께 가는 길

아래 흐름으로 함께 점검하며 약과 목표치를 맞춰 갑니다(개인별로 조정)

1

첫 평가 · 약 시작

오늘

기본 검사로 출발점을 확인하고 첫 약(대개 메트포민)을 시작합니다. 혈당 재는 법을 안내합니다.

2

약 적응 점검

1~2주 뒤

속이 불편하지 않은지 보고 필요하면 양을 늘립니다. 혈당 기록을 함께 봅니다.

3

당화혈색소 재검

약 3개월 뒤

첫 목표를 이뤘는지 보고 약·생활을 조정합니다. 안정되면 6개월 간격으로 늘립니다.

4

합병증 정기 검진

이후 해마다

눈 속·콩팥(소변·혈액)·발 검진으로 합병증을 일찍 잡고, 예방접종도 챙깁니다.

혼자 하지 않습니다

혈당 기록과 검사 결과를 진료 때 함께 보며 약과 목표치를 맞춰 갑니다. 궁금한 점은 무엇이든 물어보세요.

Tip · 궁금한 점이 생기면 메모해 두었다가 다음 진료 때 가져오세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 추적·합병증 선별 권고 · 미국당뇨병학회 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 땐 바로 연락하거나 오세요

처음에는 드물지만 급성 합병증의 경고입니다 — 망설이지 말고 알려 주세요

⚠ 저혈당(70 미만)

식은땀·떨림이면 바로 당분 약 15g(주스 반 컵·사탕 3~4개·설탕 1큰술), 15분 뒤 다시 잽니다. 의식이 흐리면 먹이지 말고 119.

심한 고혈당 · 의식 변화

구토·복통·가쁜 숨·의식 변화는 혈당과 관계없이 즉시 응급실. 증상 없이 300 이상이 계속돼도 연락하세요.

갑작스러운 시력 변화

물체가 일그러지거나 검은 점·시야 가림이 생기면 눈 속 출혈이 의심돼 바로 안과로 가세요.

낫지 않는 발 상처

2주 넘게 안 낫거나 붓고 열나고 냄새가 나면 당뇨발 진행 — 빨리 보여 주세요.

가슴 답답함 · 숨참

가슴 압박감·식은땀이 오면 바로 119에 연락해 응급실로 가세요. 당뇨는 증상이 약한 심근경색이 흔합니다.

붓기 · 거품뇨 · 소변 감소

다리 붓기·거품 소변은 콩팥 합병증 신호입니다. 바로 소변·혈액검사로 확인합니다.

Tip · 저혈당에 대비해 사탕이나 주스를 가방에 챙겨 다니세요.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 급성 합병증 · 미국당뇨병학회 2025 · 영국 JBDS-IP 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

새로운 숨참과 부종도 알려 주세요

이상언 강의 · 심부전 가능성은 증상·진찰·검사 결과를 함께 보고 판단합니다.

숨참의 여러 원인

심장 문제 외에도 폐질환, 빈혈, 근력 저하와 활동량 감소, 불안 등이 원인일 수 있습니다.

부종의 여러 원인

콩팥·간질환이나 정맥질환과도 관련될 수 있습니다. 한 증상이나 혈액검사 수치만으로 심부전으로 정하지 않습니다.

위험 단계에서 예방

당뇨병·만성콩팥병 등 위험요인이 있는 환자에서 SGLT2 억제제와 피네레논을 이용한 심부전 예방 연구를 소개했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

수포·단단한 부종·발궤양도 보여 주세요

정준민 강의에서 소개한 당뇨병 관련 피부 변화입니다.

외상 없이 생긴 수포

당뇨병수포증은 손발·하지에 수포가 생기고 2~5주에 흉터 없이 소실되는 양상으로 교재에 소개했습니다.

목·등의 단단한 부종

당뇨경화부종은 등 위쪽과 목에 통증 없이 단단한 부종이 천천히 생기고 오래 지속되는 경향이 있습니다.

발의 상처와 궤양

당뇨병 발궤양은 잘 낫지 않고 절단 원인이 될 수 있어 즉시 평가가 필요합니다. 새로 생긴 피부 변화도 함께 보여 주세요.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

첫 외래 뒤 실천할 일곱 가지

완벽하지 않아도 됩니다 — 꾸준함이 곧 치료입니다

01 약은 매일 같은 시간에 — 메트포민은 식사와 함께, 불편하면 알려 주기

02 혈당 재고 기록 — 공복·식후 2시간을 번갈아

03 접시법 + 식후 10분 걷기부터 습관으로

04 매일 발 살피기 — 맨발·뜨거운 물 주의

05 3개월 뒤 당화혈색소 재검으로 첫 목표 확인

06 금연·절주 + 예방접종 챙기기

07 다음 예약 지키기 — 궁금증·부작용은 메모해 오기

Tip · 오늘 한 가지만 골라 시작해도 충분합니다.

근거 · 대한당뇨병학회 2023 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진단은 끝이 아니라 시작입니다

궁금한 점은 언제든 물어보세요 — QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

당뇨병(제2형)을 처음 진단받은 분과 가족을 위한 안내자료입니다. 목표치와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한당뇨병학회(KDA) 진료지침 2023 · 2025 합의문 · 미국당뇨병학회(ADA) 진료 표준 2025 · 미국·유럽당뇨병학회 합의 2022 · 영국 UKPDS · 한국지질·동맥경화학회 2025

다시 보기 · 카톡 공유